

EcoDialysis — Résumé exécutif

ANDCS × MIT Hacking Medicine · Track 1 Soins durables · Paris 2026

La vulnérabilité hydrique cachée de la dialyse

Accroche Un centre de 100 patients rejette discrètement ~4 200 m³/an de rejet OI de haute pureté — une eau déjà payée, traitée et perdue. Le décret n°2024-796 (en vigueur le 1er septembre 2024) autorise désormais la réutilisation non clinique via le cadre EICH. La France peut transformer la dialyse, risque hydrique caché, en actif mesurable de résilience hydrique.

~4 200 m³ rejet OI / an / centre	2–4 ans retour indicatif	~30 k€ capex ancre (Saint-Exupéry)	1 128 m³/an précédent français mesuré	156 séances par patient / an
-------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--	---------------------------------

Ce que nous livrons - Métrologie 4 points (alim, perméat, rejet, réutilisation). - Carte de réutilisation sur mesure : vert / orange / rouge. - Dossier EICH + pré-instruction ARS. - Intégration matériel (cuve, UV-C, anti-retour, signalisation, carnet sanitaire). - SaaS de traçabilité : KPIs, m³ économisés, € vérifiés, discipline des allégations.	Base de preuves - UK : Canterbury (800 L/h, 7,5 k€/an), Bristol (13 140 m³/an), Ashford design-in 2,5 k€. - ANZ : cluster ANZSN — >160 000 L & 6,4 MWh/an économisés. - Espagne : 20 centres, moyenne 476,5 L/séance. - FR : Saint-Exupéry ~1 128 m³, ~30 k€, 5–6 ans. - SFNDT 2026 : Qd 500 → 400 ml/min économise ~24 L dialysat + 60–100 L prétraitée/séance.
--	--

Trois premiers pilotes — ce dont nous avons besoin

CHU / CHRU Vitrine de référence, voie EICH complète, crédibilité publique.	Groupe privé GHT Réplicabilité sur 6–10 centres, accord-cadre achats.	Grand centre privé indépendant Vitesse : 18 semaines, rétrofit couplé au remplacement OI.
--	---	---

Demande : 3 lettres d'intention pilotes · accès aux factures d'eau, journaux OI, planning des séances · sponsor (direction ou services techniques) · soutien pré-instruction ARS.

Discipline — ce que nous refusons

- Aucune réutilisation à contact patient. Aucun recyclage du dialysat usagé.
- Aucune allégation « neutre carbone » ou « impact zéro ». Caveat carbone eau : ~1,0–1,1 tCO₂e sur 4 200 m³ — réel mais secondaire ; le cas principal est résilience & OPEX.
- Aucun verrouillage fournisseur. Métrologie neutre, intégrateur neutre.

Sources : guides SFNDT 2023 & 2026 · Décret n°2024-796 / EICH · Planification écologique du système de santé · The Shift Project · IRDES · HCWH · synthèses deep-research (Perplexity / OpenAI / Gemini). Bibliothèque de preuves complète en annexe du deck principal (slides A1–A16 + registre des sources).